

12 - 6 Gestion des émotions

(0:01 - 0:41)

Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous retrouver encore une fois pour traiter une situation de communication clinique spécifique, qui est la gestion des émotions et qui vient compléter notre cours sur l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Les objectifs du cours sont caractériser les émotions, décrire l'intérêt de la gestion des émotions dans la relation de soins et décrire un modèle de gestion des émotions. Une émotion est une sensation plus ou moins nette de plaisir, ou de déplaisir, que l'on peut reconnaître en soi ou prêter aux autres par extrapolation.

(0:42 - 1:18)

Il s'agit d'une notion complexe, car elle comporte un aspect psychique ou mental, c'est-à-dire ce qu'on ressent, la joie, le chagrin et autres, et un aspect physique, ce sont les manifestations physiologiques de l'émotion. Les relations médecin-malade peuvent être source d'émotions, car le patient peut exprimer des souffrances et se créer, se confier à son médecin. Le médecin n'est pas à l'abri de des charges émotionnelles, angoisses, doutes, dans une relation qui est très exigeante.

(1:20 - 2:09)

Parfois c'est une relation conflictuelle d'omblet ou mal ressentie. Elle est toujours différente d'un malade à l'autre, d'une famille à l'autre, d'un moment à l'autre, c'est ce qui fait la complexité de la relation médecin-malade. Je vous ai mis ici plusieurs expressions faciales des émotions.

Je vous demande de ne pas lire l'émotion et d'essayer de déduire vous-même les différentes émotions sur cette diapositive. On va traiter ça dans la séance interactive. Il y a six types d'émotions simples.

(2:10 - 2:23)

Qui sont relatives essentiellement à la survie de l'individu. La colère, la joie, le dégoût, la surprise, la tristesse et la peur. On décrit aussi ce qu'on appelle les émotions secondaires.

(2:25 - 2:52)

C'est l'association d'émotions simples. Par exemple la honte et l'association de la colère plus la peur. À quoi servent les émotions ? Les émotions et particulièrement celles de l'excitation, de la colère et la peur, correspondent à un réflexe naturel qui permet aux êtres vivants de devenir momentanément plus fort et plus rapide devant ce qui les met en danger.

(2:56 - 3:23)

Plusieurs théories ont été émises pour expliquer l'origine des émotions, notamment la théorie cognitiviste, physiologiste, évolutionniste et autres. Je vous ai choisi une technique simple. Il y a plusieurs techniques de gestion des émotions, mais dans ce cours-là, je vous ai choisi une technique plutôt simple de gestion des émotions.

(3:24 - 3:41)

C'est le modèle NURSE. N pour Naming, U pour Understanding, R pour Respecting, S for Supporting et E for Exploring. On va détailler chaque étape.

(3:46 - 4:04)

D'abord Naming, c'est-à-dire nommer les émotions. Le fait de mettre un nom sur l'émotion consiste à reformuler, c'est-à-dire utiliser la technique de reformulation. Le sentiment éprouvé par le patient est nommé tel qu'il est perçu.

(4:06 - 4:28)

Cette étape est pertinente lorsque le patient n'a pas déjà exprimé lui-même ses sentiments. Le fait de nommer les sentiments permet de diminuer l'intensité de l'émotion. Understanding, c'est exprimer de la compréhension pour les émotions du patient et pour son vécu.

(4:29 - 4:47)

Tout particulièrement dans les cas où les patients relâchent des situations de vie difficiles. Il est toujours possible de valoriser les efforts qu'il déploie pour s'en sortir. Troisièmement, il faut exprimer du respect, de la reconnaissance pour le patient.

(4:49 - 5:07)

Quatrièmement, apporter son soutien au patient. Et à la fin, investiguer d'autres aspects propres aux émotions. Cette investigation est particulièrement conseillée lorsque le médecin ne perçoit pas l'état émotionnel du patient de façon claire.

(5:10 - 5:48)

Et je vous invite à revenir à la deuxième diapositive où je vous ai mis les différents émotions. Je vous ai donné ici un exemple du modèle NURSE qu'on pourrait traiter dans les séances interactives. En conclusion, l'appréhension et les difficultés éprouvées par les médecins vis-à-vis de la gestion des réactions émotionnelles des patients à cause de leur manque de formation à la question.

(5:49 - 5:59)

Il faut apprendre à gérer les réactions émotionnelles des patients et ce par l'acquisition de

stratégies de soutien, reconnaissance, empathie et réassurance.